分子线 档案 A · 患者本人视角 | 图谱 CML-MOL | 记录者随条目标注

趋势与词表 | 指标卡（分系列·翻面） | 复查记录 CML-LAB（二级）

状态与缩放

有数据 | 空态 | 单点 | 错误态（拒收候选）

时间范围（缩放）：**全部** | 近 12 个月 | 近 6 个月 | 近 3 个月

纵轴刻度：**线性（按值）** | 对数

指标（多选 ≤4）：**BCR::ABL1（IS%）** | 白细胞 | 中性粒细胞 | 血红蛋白 | 血小板 | 副作用记录 | 月自费金额

分类值（kind=qual/grade，如副作用记录）不进曲线，只在下方按事件列出。

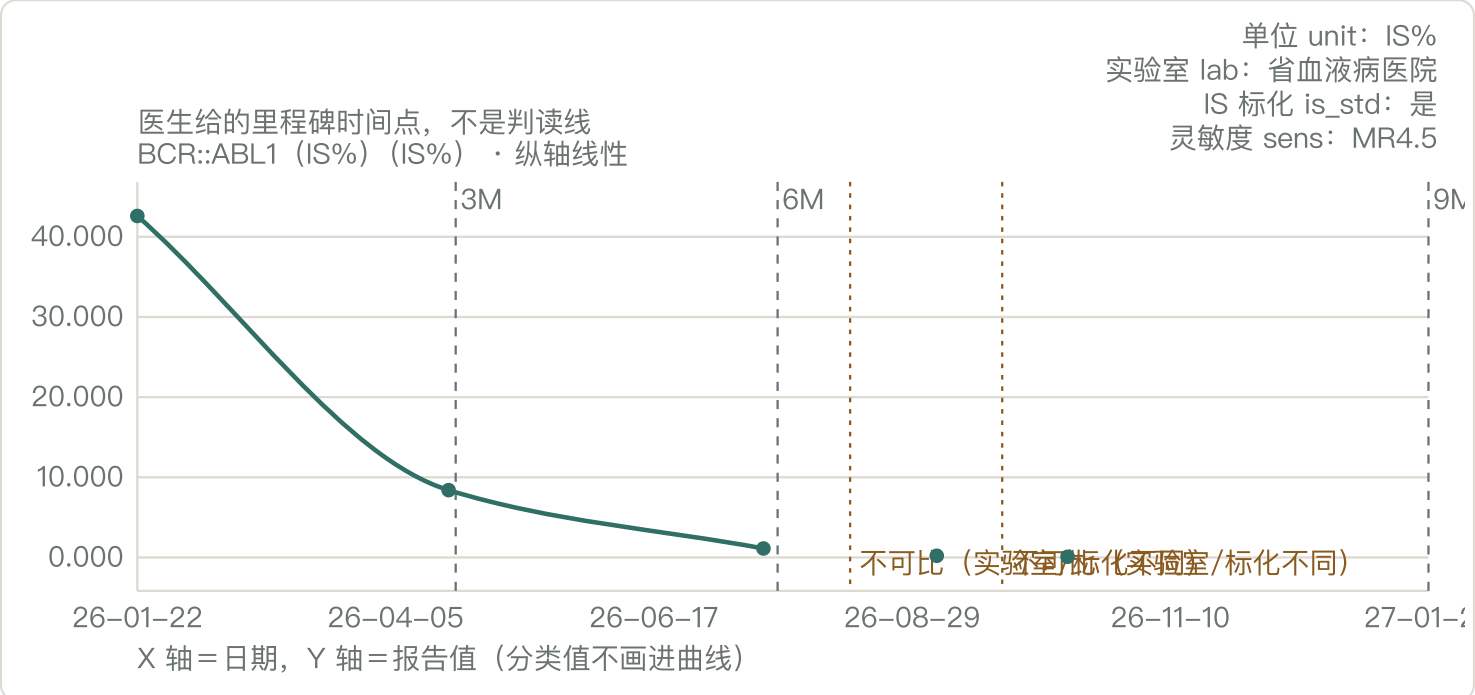
趋势

SVG class="chart" | Fritsch–Carlson 单调三次插值

里程碑角标（点开看词义与来源版本）：IS% | MMR | MR4 | MR4.5 | CMR / DMR | 临床研究核对字段

资料导入（候选 → 核对）

BCR::ABL1（IS%）（IS%）



单位：IS%　纵轴：线性　参考线：3 / 6 / 12 月（灰虚线）　参考线含义：医生给的里程碑时间点，不是判读线

口径：数值只抄报告原文；不同实验室/未 IS 标化不可直接连成一条线（趋势页会分段）

> 引指南口径（来源：中国 CML 诊疗指南 2025 版）：“不建议根据 BCR::ABL1 IS 的单次、单一数值做出转换治疗的决策”
> 来源：中国 CML 诊疗指南（2025 版）· 分子学监测章节

实验室与可比性（HVT-07 四要素） unit / lab / is_std / sens

日期	值	单位 unit	实验室 lab	IS 标化 is_std	灵敏度 sens	来源	记录者
2026-01-22	42.600	IS%	省血液病医院	是	MR4.5	确诊基线	记录者：本人
2026-04-20	8.400	IS%	省血液病医院	是	MR4.5	3 个月里程碑	记录者：本人
2026-07-18	1.120	IS%	省血液病医院	是	MR4.5	6 个月里程碑	记录者：本人
2026-09-05	0.210	IS%	外院（华山医院）	否	未注明	外地出差就近复查，外院未做 IS 标化	记录者：本人
2026-10-12	0.086	IS%	省血液病医院	是	MR4.5	12 个月里程碑	记录者：本人

> 相邻两点「实验室不同」或「IS 标化不为 1」→ 图上断开折线并标注「不可比（实验室/标化不同）」。任一要素缺失时显示「未记录」。

可比性演示：把最近一点按「外院 / 未 IS 标化」渲染　仅视图层演示，不改动 demo-data.js

词表（HVT-01 转录本 / HVT-02 分期 / 里程碑）

转录本类型	口径原文	本档案	来源
e13a2（典型）	BCR 外显子 13 与 ABL1 外显子 2 融合	—	血液科 2026-01-22 RT-PCR
e14a2（典型）	BCR 外显子 14 与 ABL1 外显子 2 融合	本档案	血液科 2026-01-22 RT-PCR
非典型转录本	需高标准实验室定量（阈值口径照抄报告）	—	中国 CML 诊疗指南（2025 版）

分期	原始阈值口径	来源版本
CP 慢性期	原始细胞（骨髓/外周血）<10%，无 AP/BP 特征	ICC2022
AP 加速期	原始细胞 10–19%，或出现指定额外染色体发现（ACA）等口径	ICC2022
BP 急变期	原始细胞 ≥20%（髓系/淋系/双表型按报告原文）	ICC2022

> 分期词表只放阈值与版本，不出现「你属于哪期」这类结论。

里程碑词	报告里怎么写	口径原文（照抄）	来源版本
CMR / DMR	完全分子学缓解	BCR::ABL1 IS ≤0.01%（MR3 以下）口径按指南原文	GL-CN-2025
MMR	主要分子学缓解	BCR::ABL1 IS ≤0.1%，需同一实验室、IS 标化可比	GL-CN-2025
MR4	4 log 深度缓解	BCR::ABL1 IS ≤0.01% 且灵敏度足够	GL-CN-2025
MR4.5	4.5 log 深度缓解	BCR::ABL1 IS ≤0.0032% 且灵敏度达 MR4.5	GL-CN-2025

里程碑词	报告里怎么写	口径原文（照抄）	来源版本
MR5	5 log 深度缓解	BCR::ABL1 IS ≤0.001%（需实验室支持）	GL-CN-2025

> 词表只给词义与来源版本，不做「是否达到」的判读。

复查记录（二级：录入 / 更正）

显式编辑 ≤1/页　记录者：本人

日期

2026-10-13

BCR::ABL1（IS%）

实验室 lab

IS 标化 is_std（1=是 / 0=否）

1

灵敏度 sens

MR4.5

单位 unit

IS%

保存（写入本机内存态）　改这一条（更正，不删除）　模拟候选被拒收

删除 = 更正：界面只出现「改这一条 / 更正」，历史版本同链可回溯。

本机新增的复查记录（0 条，内存态）

还没有本机新增记录；保存后这里会列出，并同步进趋势图与复诊资料包。

治疗路径（默认概要，按需展开细节）

阶段数 4　默认全部收起

● **确诊与一线起始** 2026-01-22 → 2026-05-07 确诊慢性期 CML（e14a2），开始伊马替尼 400 mg 每日 展开细节

方案

伊马替尼 400 mg · 每日 1 次 · 2026-01-24 起

药名 / 剂量	伊马替尼 400 mg
频次	每日 1 次（daily）
起止	2026-01-24 起
计划 vs 实际	计划：持续至医生评估；实际：2026-05-08 减量至 300 mg（见下一阶段）
凭据	血液科门诊 2026-01-24（文件 A-D1）

指标和趋势

基线 BCR::ABL1 IS 42.6%；白细胞 28.6 → 5.1（10^9/L）

BCR::ABL1（IS%）	2026-01-22：42.6%（省血液病医院 · IS 标化 · 灵敏度 MR4.5）
白细胞（10^9/L）	2026-01-22：28.6 → 2026-04-02：5.1；原报告参考区间 3.5—9.5（仅照抄）
血小板（10^9/L）	2026-01-22：320 → 2026-04-02：168
趋势一句话	阶段内 4 次血常规 + 1 次 qPCR 逐点抄录；连线与分段见分子线页

影像发现

无 · 说明：本阶段未做影像检查

影像报告	无
说明	确诊依据为血常规 + 骨髓细胞遗传学 + 融合基因报告（A-D1、A-D2），不是影像

副作用总结

1 条：白细胞偏低（处理原文已引）

2026-05-06 白细胞偏低	记录原文：“化验单上白细胞 3.1，没有不舒服” 来源：文件 A-D3
等级	报告未给等级字段（本页不代拟等级）
处理原文	“减量后复查” 来源：血液科门诊 2026-05-06

心理与营养措施和效果

活动照常；1 条本人记录

措施	每天早饭后吃药；每周三次快走 40 分钟（本人自述）
效果（本人原话）	“有点烦：每天吃药像闹钟，出差要算时差” 来源：本人记录 2026-03-10
说明	效果只照抄本人原话，不评疗效

● **减量观察** 2026–05–08 → 2026–08–14 血象偏低后减量至 300 mg，继续每日口服 展开细节

方案

伊马替尼 300 mg · 每日 1 次 · 2026–05–08 → 2026–08–14

药名 / 剂量	伊马替尼 300 mg
频次	每日 1 次
起止	2026–05–08 → 2026–08–14
变更原因原文	“白细胞和血小板都低了，先减到 300mg 观察” 来源：血液科门诊 2026–05–08
凭据	血液科门诊 2026–05–08（文件 A–D3）

指标和趋势

BCR::ABL1 2026–07–18：1.12%；白细胞 3.1 → 4.6

BCR::ABL1（IS%）	2026–07–18：1.12%（省血液病医院 · IS 标化 · MR4.5）
白细胞（10^9/L）	2026–05–06：3.1 → 2026–08–06：4.4
血小板（10^9/L）	2026–05–06：142 → 2026–08–06：204
趋势一句话	3 个月节点 qPCR 逐点抄录；本页不连线判读

影像发现

无 · 说明：本阶段未做影像检查

影像报告	无
说明	本阶段文件为血常规与 qPCR 报告（A–D3）

副作用总结

2 条：眼睑水肿、肌肉痉挛（小腿）

2026–07–20 眼睑水肿	自述原文：“早上起床眼皮肿，下午好些” 来源：本人自述
2026–06–18 肌肉痉挛（小腿）	自述原文：“夜里小腿抽筋，一周 2–3 次” 来源：本人自述
处理原文	“自述；医生说可以补充镁，具体听门诊” 来源：血液科门诊口述记录
等级	报告未给等级字段（本页不代拟等级）

心理与营养措施和效果

无新增措施记录 · 说明：本阶段没有再记支持措施

措施	无
效果（本人原话）	本阶段无记录

说明	无内容即写「无 + 说明」，不省略块

● **换药与胸腔积液处理** 2026–08–15 → 2026–09–30 换达沙替尼 50 mg；9 月记录胸腔积液 / 气促并门诊处理 展开细节

方案

达沙替尼 50 mg · 每日 1 次 · 2026–08–15 起

药名 / 剂量	达沙替尼 50 mg
频次	每日 1 次
起止	2026–08–15 起
变更原因原文	“胸腔积液考虑和伊马替尼无关，换达沙替尼，先用 50mg” 来源：血液科门诊 2026–08–15
凭据	门诊病历 2026–08–15（文件 A–D5）

指标和趋势

阶段内 2 次血常规；本阶段无 qPCR

白细胞（10^9/L）	2026–08–06：4.4 → 2026–09–03：4.8
血红蛋白（g/L）	2026–08–06：130 → 2026–09–03：134
BCR::ABL1（IS%）	本阶段无复查（下一次 2026–10–12）

影像发现

1 份影像报告；结论原文待逐字核对入库

报告	胸部 CT 报告 2026–09–02（文件 A–D6，已解析）
结论原文	尚未逐字核对入库；本页不代拟结论，也不做判断
说明	影像块只放报告原文；核对完成后回填此处

副作用总结

1 条：胸腔积液 / 气促（处理原文已引）

2026–09–02 胸腔积液 / 气促	自述原文：“爬两层楼就喘，躺下更明显” 来源：本人自述
处理原文	“先停药三天复查胸片” 来源：医生原话 · 血液科门诊 2026–09–02
凭据	胸部 CT 报告 2026–09–02（文件 A–D6）
等级	报告未给等级字段（本页不代拟等级）

心理与营养措施和效果

1 条本人记录；活动改为散步

措施	胸腔积液期间把快走改成散步（本人自述）
效果（本人原话）	“吓了一跳：喘不上气那两天以为心脏出问题，结果是胸腔积液” 来源：本人记录 2026–08–20

营养	本阶段无营养措施记录

● **维持与随访** 2026–10–01 → 至今 达沙替尼 50 mg 维持；10–12 完成 12 个月随访 qPCR 展开细节

方案

达沙替尼 50 mg · 每日 1 次 · 继续

药名 / 剂量	达沙替尼 50 mg
频次	每日 1 次
起止	2026–08–15 起，持续中
计划 vs 实际	计划：每日 1 次；实际：10 月记录 11 天已服 / 1 天漏服（见服药线）
凭据	门诊病历 2026–08–15（文件 A–D5）

指标和趋势

BCR::ABL1 2026–10–12：0.086%；血常规白细胞 5.0

BCR::ABL1（IS%）	2026–10–12：0.086%（省血液病医院 · IS 标化 · MR4.5）
白细胞（10^9/L）	2026–10–12：5.0
血小板（10^9/L）	2026–10–12：222
血红蛋白（g/L）	2026–10–12：138
趋势一句话	逐点抄录，分段与连线见分子线页

影像发现

无 · 说明：本阶段未新增影像检查

影像报告	无
说明	最近一份影像为 2026–09–02 胸部 CT（文件 A–D6）

副作用总结

无新增副作用记录 · 说明：本阶段尚未记录新条目

条目	无
说明	空态按 docs/UI–DESIGN.md §四：副作用日志显示词表引导，不显示空白表

心理与营养措施和效果

1 条本人记录

措施	继续每天早饭后服药、每周三次快走（本人自述）
效果（本人原话）	“还行：医生说数值在往下走，我先把这三个月过好” 来源：本人记录 2026–10–12
营养	本阶段无营养措施记录

计划 vs 实际

阶段	计划	实际
2026-01-22 → 2026-05-07 · 确诊与一线起始	伊马替尼 400 mg 每日	计划：持续至医生评估；实际：2026-05-08 减量至 300 mg（见下一阶段）
2026-05-08 → 2026-08-14 · 减量观察	伊马替尼 300 mg 每日	“白细胞和血小板都低了，先减到 300mg 观察” 来源：血液科门诊 2026-05-08
2026-08-15 → 2026-09-30 · 换药与胸腔积液处理	达沙替尼 50 mg 每日	“胸腔积液考虑和伊马替尼无关，换达沙替尼，先用 50mg” 来源：血液科门诊 2026-08-15
2026-10-01 → 至今 · 维持与随访	达沙替尼 50 mg 每日维持	计划：每日 1 次；实际：10 月记录 11 天已服 / 1 天漏服（见服药线）

口径说明：阶段按门诊记录 / 报告日期切分；「实际」只照抄处方变更线与门诊记录，不做推断。每阶段固定五块，缺内容写「无 + 说明」，不省略块。

TFR 准备（二级入口）

停药相关重大决策不 AI 生成、不出方向性措辞；本页只提供条件核对清单入口。

去 TFR 档案（条件核对清单 + 密测轨道）

本页 AI 协助

AI 协助（示例） · 按可比性分组

手工入口与二级页

二级页：复查记录 CML-LAB（血常规密测轨道 + 骨髓 / 细胞遗传学原文摘录）；资料导入（字段候选 → 逐项核对）；临床试验（M4 数据未接入）。

⋯ 更多→停药尝试准备